

Úlcera péptica perforada

1. Introducción y relevancia clínica

La **úlcera péptica perforada (UPP)** es una complicación aguda de la enfermedad ulcerosa gastroduodenal en la que se produce una **discontinuidad total de la pared gástrica o duodenal**, permitiendo la salida de contenido ácido y alimentario hacia la cavidad peritoneal, generando una **peritonitis química y luego bacteriana**.

Es una **urgencia quirúrgica** que representa hasta el **10% de todas las úlceras pépticas** y una de las **principales causas de abdomen agudo perforado**.

Afecta principalmente a varones adultos jóvenes o mayores con antecedentes de consumo de **AINEs, alcohol, tabaco o infección por Helicobacter pylori**.

La **mortalidad** varía del **5 al 15%**, aumentando con la edad, comorbilidades y retraso en la cirugía (>24 h).

Su diagnóstico es **eminente clínico-radiológico** y el tratamiento suele ser **quirúrgico con cierre del defecto + tratamiento médico antiulceroso**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Etiopatogenia

La úlcera péptica es el resultado del **desequilibrio entre los factores agresivos** (ácido, pepsina, AINEs, H. pylori) y **los factores defensivos** de la mucosa (moco, bicarbonato, flujo sanguíneo mucoso).

Cuando la erosión progresa a través de todas las capas, se produce la **perforación libre**, permitiendo la salida del contenido gástrico o duodenal hacia el peritoneo.

2.2 Factores de riesgo

- **AINEs y corticoides** (inhiben prostaglandinas protectoras).
- **Infección por H. pylori** (aumenta secreción ácida).
- **Tabaquismo y alcohol** (retardan cicatrización).
- **Estrés fisiológico grave** (quemaduras, sepsis, trauma).

- **Cirugía gástrica previa**, edad avanzada.
-

2.3 Localización

- **Duodeno (60%)**: cara anterior de la primera porción.
 - **Estómago (40%)**: generalmente en la curvatura menor o antro.
 - Raramente en yeyuno (postgastrectomía o úlcera marginal).
-

2.4 Fases fisiopatológicas de la perforación

1. **Peritonitis química (primeras 3–6 h)**: ácido clorhídrico y bilis irritan el peritoneo → dolor súbito e intenso.
2. **Peritonitis bacteriana (6–12 h)**: proliferación de flora intestinal → fiebre, leucocitosis, sepsis.
3. **Fase de shock séptico (≥ 12 h)**: taquicardia, hipotensión, abdomen rígido.

Cuanto mayor sea el tiempo entre la perforación y la cirugía, **peor es el pronóstico**.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

- **Dolor abdominal súbito, intenso, “en puñalada”**, localizado inicialmente en epigastrio y que rápidamente se generaliza.
- **Irradiación a hombros o dorso** (por irritación frénica).
- **Náuseas y vómitos** posteriores.
- **Evolución a rigidez abdominal** y signos de peritonitis difusa.

3.2 Examen físico

- **Paciente inmóvil, pálido, taquicárdico.**
- **Abdomen en tabla (“board-like rigidity”),** defensa generalizada.
- **Dolor a la descompresión brusca (Blumberg positivo).**
- **Silencio abdominal.**
- En casos avanzados: fiebre, hipotensión, shock séptico.

En ancianos o pacientes con corticoides, la presentación puede ser **atípica o insidiosa**, sin rigidez marcada.

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia clave
Perforación de víscera hueca (apéndice, divertículo)	Dolor inicialmente localizado
Pancreatitis aguda	Dolor en cinturón, amilasa/lipasa >3x
Colecistitis o colelitiasis complicada	Dolor en hipocondrio derecho, signo de Murphy
Isquemia mesentérica aguda	Dolor desproporcionado, lactato elevado
IAM inferior	ECG con cambios típicos, sin rigidez abdominal

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

- **Leucocitosis** con desviación a izquierda.
 - **PCR y procalcitonina** elevadas.
 - **Urea y creatinina** elevadas si hay deshidratación o sepsis.
 - **Amilasa y lipasa** pueden elevarse moderadamente por irritación peritoneal.
 - **Lactato** alto en shock o isquemia visceral.
-

4.2 Imágenes

A. Radiografía de tórax y abdomen de pie (o decúbito lateral izquierdo si el paciente no puede ponerse de pie)

- **Signo clásico: neumoperitoneo** (aire libre subdiafragmático).
 - Visible en el **75–80% de los casos**.
 - Mejor visualización en radiografía de tórax posteroanterior en bipedestación.

B. TAC abdominopélvico con contraste (gold standard)

- Detecta **pequeñas cantidades de aire libre** no vistas en Rx.
- Identifica el **sitio exacto de perforación**, líquido libre y abscesos.
- Evalúa **otras causas** de abdomen agudo.

C. Endoscopía digestiva alta

- **Contraindicada en fase aguda** (riesgo de peritonitis); útil solo una vez resuelta la perforación.
-

4.3 Diagnóstico

Confirmado por:

1. Dolor epigástrico súbito + signos de peritonitis.

2. Aire libre subdiafragmático en Rx o TAC.
 3. Antecedente de úlcera o uso de AINEs.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / WSES / UpToDate)

5.1 Manejo inicial

- Hospitalización inmediata.
 - Ayuno absoluto.
 - Sonda nasogástrica para descompresión.
 - Fluidoterapia intensiva: cristaloideos (Ringer lactato).
 - Profilaxis antibiótica de amplio espectro:
 - Ceftriaxona + Metronidazol o Piperacilina/Tazobactam.
 - Inhibidor de bomba de protones (IBP IV):
 - Omeprazol 80 mg bolo + 8 mg/h infusión o dosis equivalentes.
 - Evaluar riesgo quirúrgico y preparar pabellón.
-

5.2 Tratamiento definitivo

A. Cirugía (tratamiento estándar)

- Indicaciones:
 1. Aire libre o contenido libre confirmado.
 2. Peritonitis generalizada.
 3. Deterioro clínico progresivo.
- Técnicas quirúrgicas:

1. **Cierre primario con parche epiploico (técnica de Graham):**

- Estándar en perforaciones duodenales o gástricas pequeñas (<1 cm).

2. **Resección gástrica parcial (antrectomía):**

- En úlceras gástricas grandes o sospecha de neoplasia.

3. **Laparoscopia:** preferida si paciente estable y experiencia disponible; permite aspiración, lavado y cierre del defecto.

En pacientes de alto riesgo o perforación contenida, puede considerarse manejo no operatorio ("Taylor modificado").

B. Manejo no quirúrgico (selectivo)

Solo en casos muy seleccionados:

- Perforación **pequeña y sellada** (sin neumoperitoneo libre).
- Paciente **hemodinámicamente estable y sin peritonitis**.
- Confirmado por TAC (colección localizada).

Incluye:

- Ayuno, aspiración con SNG, IBP IV, antibióticos, hidratación, vigilancia clínica estricta y TAC seriada.
-

5.3 Erradicación de Helicobacter pylori

- Debe realizarse **tras la resolución del cuadro agudo**.
 - **Triple terapia estándar (14 días):**
 - IBP + amoxicilina 1 g/12 h + claritromicina 500 mg/12 h.
 - En resistencia o alergias, usar terapia cuádruple con bismuto.
-

5.4 Seguimiento

- **Endoscopia de control a las 6–8 semanas**, especialmente en úlceras gástricas (para descartar cáncer).
 - Educación sobre evitar AINEs, tabaco y alcohol.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Consecuencia
Peritonitis bacteriana difusa	Sepsis, shock séptico
Abscesos subfrénicos o pélvicos	Fiebre persistente postoperatoria
Fístula gastroduodenal	Filtración, peritonitis
Hemorragia digestiva	Úlcera sangrante concomitante
Síndrome de dumping	Tras cirugía gástrica
Recurrencia ulcerosa	Si no se erradica <i>H. pylori</i>

Pronóstico:

- Mortalidad <5% si cirugía precoz (<12 h).
 - 20% si demora >24 h o en pacientes >70 años.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dolor epigástrico súbito + abdomen en tabla + aire libre = úlcera perforada hasta demostrar lo contrario.**
 2. **Radiografía de tórax en bipedestación** es el examen más útil y disponible.
 3. **No endoscopia en fase aguda.**
 4. **Cierre con parche epiploico (Graham)** es el tratamiento quirúrgico estándar.
 5. **No demorar cirugía:** cada hora aumenta mortalidad.
 6. **Erradicar H. pylori tras estabilización** previene recurrencias.
 7. En pacientes ancianos o inmunodeprimidos, la presentación puede ser **sutil o sin rigidez abdominal**.
-



Errores comunes

- Indicar tratamiento conservador en pacientes con **peritonitis o neumoperitoneo libre**.
 - Omitir **profilaxis antibiótica o IBP IV** preoperatoria.
 - No corregir la **hipovolemia antes de anestesia**.
 - No realizar **endoscopia de control en úlceras gástricas**.
 - Ignorar la importancia de **erradicar H. pylori**.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **úlcera péptica perforada** es una urgencia quirúrgica por **perforación gástrica o duodenal** → peritonitis química y bacteriana.

2. Clínica: **dolor epigástrico súbito, rigidez abdominal, aire libre subdiafragmático.**
3. Diagnóstico: **clínico + radiografía o TAC** (neumoperitoneo).
4. Tratamiento: **cirugía urgente + antibióticos + IBP IV + fluidoterapia.**
5. **Cierre con parche epiploico (Graham)** es el estándar; resección si úlcera gástrica grande o neoplásica.
6. **Erradicación de H. pylori y control endoscópico** posterior son obligatorios.
7. El **retraso en la cirugía >24 h** multiplica la mortalidad.